

**El certificado de salud en el movimiento internacional de perros y gatos:
examen clínico, trazabilidad sanitaria y validez documental**

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

ORCID: 0009-0002-6837-5311

Serie Tecnica Vol. X - Zoovet Travel

DOI: 10.5281/zenodo.20209709

Editorial: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru - 2026-05-15

Resumen

Objetivo. Describir la naturaleza clinico-documental del certificado de salud veterinario en el movimiento internacional de perros y gatos, su fundamento sanitario, componentes de examen requeridos y causas frecuentes de invalidez. **Metodo.** Revision tecnica de los marcos regulatorios internacionales, los protocolos de examen clinico previo al transporte y los requisitos de trazabilidad documental exigidos por los principales paises de destino. **Resultados.** El certificado de salud es una declaracion tecnica bajo responsabilidad profesional veterinaria, no una garantia de ausencia de enfermedad. Su validez depende de la concordancia microchip-especie-fecha, la ventana temporal (generalmente 10 dias), el tipo de emisor autorizado y el endoso oficial cuando es exigido. Los errores de trazabilidad son la causa mas frecuente de rechazo en frontera. **Conclusion.** La distincion entre certificado veterinario y certificado oficialmente endosado es determinante para la planificacion del expediente de exportacion segun el pais de destino especifico.

Palabras clave: certificado de salud veterinario, examen clinico, trazabilidad sanitaria, endoso oficial, exportacion mascotas, validez documental, movimiento internacional

Revisión del fundamento clínico y regulatorio del certificado de salud veterinario internacional, su función en el control sanitario del movimiento de animales de compañía y la distinción entre certificado clínico y documento oficial endosado.

Jessica Ysabel Camacho Garcia, MVZ -- CMVP 12434 -- Zoovet Travel, Lima, Perú | Revisión: febrero 2026

Sección 1 Qué es un certificado de salud: acto clínico e instrumento de control sanitario

1.1 Naturaleza clínico-documental

El certificado de salud es la formalización escrita de un examen clínico realizado con un propósito específico: determinar si un animal presenta, en el momento del examen, condiciones clínicas compatibles con el transporte internacional y con los requisitos sanitarios del destino. No es un documento de diagnóstico ni un informe médico completo: es una declaración técnica acotada, con alcance definido y fecha de referencia precisa.

Entender esta naturaleza doble --clínica en su origen, documental en su función-- es esencial para interpretar correctamente tanto sus posibilidades como sus límites. El certificado de salud traduce un evento biológico --el estado del animal en un momento dado-- a un formato administrativo estandarizado que pueda ser leído, interpretado y verificado por personas y sistemas que no estuvieron presentes en el examen.

Esa traducción introduce, inevitablemente, una simplificación. El estado clínico de un animal es continuo y dinámico; el certificado lo captura como una fotografía estática. Esta limitación no invalida el instrumento: define su alcance. El control sanitario internacional opera sobre documentos porque no puede operar sobre individuos en tiempo real. El certificado es el mejor aproximador disponible dentro de esa restricción.

1.2 Certificado vs. garantía: una distinción que no debe perderse

La palabra «certificado» induce frecuentemente una interpretación errónea: que el documento certifica, en el sentido de garantizar, que el animal está libre de enfermedad. Esta interpretación no es técnicamente correcta y, cuando guía las decisiones de los propietarios o de los operadores de transporte, genera expectativas que el instrumento no puede satisfacer.

Lo que el certificado de salud acredita es que un veterinario habilitado examinó al animal en una fecha específica y no encontró, en ese examen, hallazgos clínicos que contraindiquen el transporte bajo las condiciones descritas. Eso es funcionalmente distinto de garantizar que el animal está sano en sentido absoluto, que no es portador de ningún agente infeccioso, o que no desarrollará enfermedad durante o después del viaje.

La diferencia no es semántica. Un animal puede superar un examen clínico con resultado favorable y estar en el período de incubación de una enfermedad que aún no produce signos detectables. Un animal puede tener una condición subclínica que no sea relevante para el transporte pero que aparezca después del viaje. El sistema de control sanitario internacional conoce estas limitaciones y las gestiona con otros instrumentos --vacunación, pruebas serológicas, cuarentena-- precisamente porque el certificado de salud solo puede hacer lo que un examen clínico puede hacer.

1.3 El veterinario emisor: declaración técnica bajo responsabilidad profesional

La firma del veterinario en un certificado de salud no es una validación formal de un formulario completado. Es una declaración técnica bajo responsabilidad profesional que afirma que el examen fue realizado, que los hallazgos registrados corresponden a lo observado, y que el criterio clínico del profesional sustenta las afirmaciones contenidas en el documento.

Esta responsabilidad tiene implicaciones prácticas en ambos sentidos. El veterinario no puede firmar un certificado de salud basándose en un examen no realizado, en datos referidos por terceros, o en documentación anterior sin examen actual. Y tampoco puede completar un certificado con afirmaciones que su examen no sustenta. En jurisdicciones

donde el certificado de salud requiere endoso por autoridad sanitaria, el emisor inicial debe ser consciente de que su declaración será revisada y potencialmente validada o rechazada por un tercero con competencia legal para ello.

Sección 2 Fundamento sanitario: por qué los Estados exigen certificados de salud

2.1 Bioseguridad y control de la introducción de patógenos

El movimiento internacional de animales de compañía es, desde la perspectiva de la epidemiología veterinaria, un vector potencial de introducción de agentes infecciosos en poblaciones animales y humanas que no han tenido contacto previo con ellos. La historia de la sanidad animal internacional registra casos documentados de introducción de enfermedades a través del movimiento legal e ilegal de animales de compañía, lo que justifica la existencia de sistemas de control independientemente del riesgo individual de cada animal concreto.

El certificado de salud es uno de los instrumentos de ese sistema de control. Su función no es primariamente proteger al animal que lo porta --aunque puede contribuir a ello-- sino proteger las poblaciones animales y humanas del territorio receptor. Esta perspectiva de salud pública veterinaria explica por qué los Estados exigen documentación incluso para animales procedentes de países con alta prevalencia de vacunación y baja incidencia de enfermedades relevantes: el riesgo no es solo el animal individual, sino la cadena de transmisión que podría iniciarse si un portador asintomático entra en contacto con una población receptora naive.

2.2 Riesgo individual vs. riesgo poblacional

La distinción entre riesgo individual y riesgo poblacional, ya introducida en el Artículo 9 de esta serie en el contexto de la vacunación, es igualmente central para entender el certificado de salud. Un animal concreto puede tener un riesgo individual extremadamente bajo de portar o transmitir cualquier patógeno relevante. Pero el sistema de control

sanitario no evalúa animales individuales: evalúa flujos de animales y gestiona probabilidades colectivas.

Si un millón de animales cruzan una frontera por año y el sistema exige certificado de salud, el objetivo no es detectar los pocos portadores entre el millón --esa capacidad diagnóstica está por encima de lo que un examen clínico puede ofrecer-- sino crear un mecanismo de trazabilidad que permita, cuando ocurre un evento sanitario, reconstruir los movimientos implicados, identificar el origen del problema y contener su extensión.

Esta función de trazabilidad retroactiva es, en muchos casos, más importante que la función de cribado prospectivo del certificado. Un certificado que no puede ser rastreado hasta el animal concreto que lo porta, hasta el veterinario que lo emitió, y hasta el momento exacto del examen, ha perdido su utilidad principal como instrumento de control sanitario poblacional.

2.3 Por qué existen ventanas temporales de validez

El certificado de salud tiene una fecha de emisión y una ventana de validez: un período después del cual el documento deja de ser aceptado por las autoridades de destino, independientemente de la corrección de su contenido. Esta caducidad documental es frecuentemente percibida como un requisito burocrático arbitrario, pero tiene fundamento en la lógica del control de riesgo.

Un examen clínico realizado hace treinta días describe el estado del animal hace treinta días. Un animal que estaba clínicamente sano hace treinta días puede haber desarrollado una enfermedad en ese intervalo, o puede haber sido expuesto a un agente infeccioso que aún está en período de incubación. Cuanto mayor es el intervalo entre el examen y el viaje, menor es la información que el certificado aporta sobre el estado actual del animal.

Las ventanas temporales exigidas por los distintos destinos --que varían y deben verificarse con la autoridad competente de cada jurisdicción en cada caso concreto, ya que no son universales ni estáticas-- reflejan el balance entre la practicidad logística (el

propietario necesita tiempo para organizar el viaje tras el examen) y la utilidad informativa del documento (el estado clínico del momento del examen debe ser razonablemente próximo al estado clínico del momento del viaje). Ese balance es una decisión de política sanitaria, no una inferencia biológica directa.

Sección 3 Componentes clínicos típicos del examen

Nota editorial -- Sección 3 Los componentes descritos en esta sección reflejan lo que la práctica regulatoria y la literatura clínica veterinaria describen como contenido habitual de un examen orientado a la emisión de certificado de salud para transporte internacional. No constituyen un protocolo prescriptivo ni una guía clínica. La selección de hallazgos y maniobras depende del caso concreto, de los requisitos del destino y es decisión exclusiva del veterinario responsable.

3.1 Identificación y concordancia documental

El primer componente del examen orientado a certificación no es clínico en sentido estricto: es la verificación de que el animal frente al veterinario es el animal descrito en los documentos que acompañan al expediente. Esto implica la lectura del microchip con lector compatible y la comprobación de que el número obtenido coincide exactamente con el registrado en los documentos sanitarios previos. Es el paso más frecuentemente omitido en exámenes apresurados y el que genera el error con mayor impacto en frontera.

3.2 Evaluación del estado general

La evaluación general del animal incluye la valoración del nivel de conciencia y respuesta al entorno, la condición corporal, el estado de hidratación aparente, y la actitud general. Estos parámetros, evaluados de forma observacional y mediante palpación básica, proporcionan información sobre el estado sistémico del animal y sobre su tolerancia previsible al estrés del transporte.

En el contexto específico del certificado de salud para transporte internacional, lo relevante no es un diagnóstico exhaustivo sino la detección de signos que contraindiquen el viaje en las condiciones previstas: signos de enfermedad activa, compromiso sistémico, deshidratación significativa, o condición corporal extrema. La ausencia de esos hallazgos es lo que el certificado declara; no la ausencia de toda patología.

3.3 Sistemas relevantes para el transporte

Los marcos regulatorios y la práctica clínica orientada a certificación suelen contemplar la evaluación de los sistemas con mayor relevancia para la tolerancia al transporte aéreo:

- Sistema respiratorio (observacional): frecuencia y patrón respiratorio en reposo, presencia de disnea, esfuerzo respiratorio aumentado o secreciones evidentes. En razas braquicéfalas, este componente adquiere particular relevancia dado el perfil de riesgo descrito en el Artículo 8 de esta serie.
- Sistema cardiovascular (básico): frecuencia cardíaca y calidad del pulso en el contexto del examen. Hallazgos que sugieran descompensación cardiovascular relevante para el transporte.
- Estado neurológico aparente: nivel de conciencia, respuesta a estímulos, capacidad de deambulación. Signos neurológicos activos que comprometan la capacidad del animal de tolerar el confinamiento o que indiquen patología central activa.
- Tegumento y ectoparásitos visibles: algunos destinos exigen la declaración de ausencia de ectoparásitos visibles como parte del certificado de salud. La evaluación del tegumento también puede revelar signos dermatológicos compatibles con condiciones zoonóticas relevantes para el destino.
- Signos compatibles con enfermedad infecciosa activa: fiebre, linfadenopatía generalizada, secreciones mucosas activas, o cualquier hallazgo compatible con proceso infeccioso en curso son hallazgos cuya presencia contraindica la emisión del certificado en ese momento.

3.4 Lo que el examen no puede descartar

Tan importante como lo que el examen evalúa es la claridad sobre lo que no puede descartar. Un examen clínico de duración razonable, sin pruebas complementarias, no puede descartar infección subclínica, estados de portador asintomático, patología orgánica sin manifestación clínica externa, o enfermedades en período de incubación. El certificado de salud que resulta de ese examen tampoco puede hacerlo. Esta limitación es inherente al instrumento y debe ser comprendida por todos los actores del proceso: veterinario, propietario, operador de transporte y autoridad sanitaria.

Sección 4 Ventanas temporales y validez: biología vs. administración

4.1 El fundamento de las ventanas temporales

La ventana temporal de validez de un certificado de salud --el período entre su emisión y el momento del viaje en que sigue siendo aceptado-- es uno de los aspectos más frecuentemente malinterpretados del sistema documental de transporte internacional. No existe una única ventana universal: cada destino, y en algunos casos cada operador de transporte, establece la suya propia, que puede variar entre 24 horas y 10 días o más, dependiendo de múltiples factores.

Lo que sí es universal es la lógica subyacente: el estado clínico de un animal es temporal. Un certificado emitido hace una semana describe el estado del animal hace una semana. La ventana temporal es el período durante el cual el sistema regulatorio considera que existe una proximidad temporal suficiente entre el examen y el viaje para que el documento siga siendo informativo sobre el estado actual del animal.

Cuando la ventana temporal expira, el certificado no se vuelve médicamente inútil: sigue describiendo lo que el veterinario encontró en su momento. Lo que pierde es su validez administrativa: el sistema de control del destino ya no lo acepta como representación adecuada del estado actual del animal.

4.2 La implicación logística de las ventanas cortas

Las ventanas temporales más cortas --las que requieren que el examen y la emisión del certificado se realicen en los días inmediatamente anteriores al viaje-- tienen una implicación logística directa: el examen no puede realizarse con antelación suficiente para que el propietario reorganice el viaje si se detectan hallazgos que contraindiquen la emisión del certificado.

Esta es, desde la perspectiva de la planificación del transporte internacional de animales, una de las variables de mayor riesgo operacional. Un animal que presenta un proceso febril leve el día anterior al vuelo, o que acaba de ser sometido a un procedimiento veterinario que el examinador considera relevante para el transporte, puede encontrarse en una situación en que el certificado no puede emitirse y el viaje debe suspenderse o posponerse con las consecuencias logísticas y económicas que eso implica.

La gestión de este riesgo no está en ampliar artificialmente las ventanas temporales --eso comprometería su función de control-- sino en planificar con suficiente margen de tiempo para que una eventualidad médica en los días previos al viaje pueda resolverse sin comprometer el calendario general.

4.3 Ventanas del certificado vs. ventanas del expediente completo

El certificado de salud tiene su propia ventana de validez, pero no es el único documento del expediente sanitario con fecha de referencia. La vacunación antirrábica tiene un período de validez. El RNATT, cuando es exigido, tiene una fecha de referencia. Los tratamientos antiparasitarios, cuando son requeridos, tienen una ventana específica en relación con la fecha de entrada al destino. El propio certificado de exportación oficial, en los sistemas que lo contemplan, puede tener una ventana de emisión acotada.

La coherencia temporal de todos estos documentos entre sí --y de cada uno de ellos con la fecha de viaje-- es uno de los elementos de verificación más complejos del proceso de exportación. Un expediente en el que cada documento cumple individualmente con sus requisitos pero en el que las fechas no son coherentes entre sí puede ser rechazado en frontera con la misma consecuencia que si alguno de los documentos faltara.

Sección 5 Coherencia documental y trazabilidad: el punto donde fallan los viajes

Si hay un patrón común en los problemas documentales que generan retrasos, rechazos o cuarentenas no planificadas en el movimiento internacional de animales de compañía, es la inconsistencia interna del expediente: documentos que individualmente son correctos pero que no son coherentes entre sí, o que no corresponden al animal que se presenta en frontera. La trazabilidad --la capacidad de vincular inequívocamente al animal individual con toda su cadena documental-- es el principio que el sistema de control verifica de forma sistemática.

5.1 El microchip como hilo conductor del expediente

El número de microchip ISO de 15 dígitos es el identificador que debe aparecer de forma exacta e idéntica en cada documento del expediente sanitario: el certificado de salud, el certificado de vacunación, el resultado del RNATT cuando aplique, el pasaporte europeo o el health certificate oficial, y cualquier documento adicional exigido por el destino o el operador.

Esta redundancia no es innecesaria: es el mecanismo que permite la verificación cruzada. Si el número de microchip varía entre documentos --aunque sea en un solo dígito-- la coherencia del expediente se rompe. La autoridad de control en frontera no puede asumir que la discrepancia es un error tipográfico: debe asumir que los documentos podrían corresponder a animales diferentes. Las consecuencias documentales de esa ambigüedad son, en la mayoría de los sistemas, la detención del movimiento hasta que se esclarezca la inconsistencia.

5.2 Errores técnicos frecuentes que invalidan el certificado

El análisis de los problemas documentales más frecuentes en el movimiento internacional de animales permite identificar una taxonomía recurrente de errores. Ninguno requiere mala fe; la mayoría son el resultado de procesos apresurados o de supuestos incorrectos sobre la normativa del destino:

5.3 La verificación como práctica sistemática, no excepcional

La revisión sistemática del expediente completo --verificando que cada documento es internamente correcto y que todos son coherentes entre sí-- no debería ser un paso de emergencia realizado el día antes del viaje. Es una práctica que, incorporada al proceso de preparación con suficiente antelación, permite identificar y corregir la mayoría de los errores antes de que tengan consecuencias irreversibles.

La regla práctica más útil es leer cada documento como si fuera el primero: sin asumir que lo que figura en los demás documentos es consistente con este. Y verificar el número de microchip en cada uno de ellos, comparándolo con el leído directamente en el animal, antes de dar el expediente por cerrado.

Sección 6 Diferencia crítica: certificado veterinario vs. certificado oficial endosado

6.1 Dos tipos de documentos, dos niveles de validez

En el sistema internacional de control sanitario del movimiento de animales de compañía coexisten dos tipos de documentos que frecuentemente se confunden bajo el término genérico de «certificado de salud»:

- El certificado veterinario: emitido por un veterinario habilitado en el ejercicio privado de su profesión, sobre la base de su examen clínico y su criterio profesional. Es un documento médico con responsabilidad profesional individual. Su validez es la del profesional que lo firma.
- El certificado oficial o documento endosado: es el resultado de un proceso en el que el certificado veterinario, o una versión oficial del mismo, es revisado y validado por una autoridad sanitaria competente del Estado. Este endoso transforma el documento: ya no es solo la declaración de un profesional privado, es un documento oficial respaldado por la autoridad del Estado emisor.

Esta distinción no es formalista. Tiene implicaciones directas en el valor que el Estado receptor asigna al documento. Un certificado veterinario sin endoso oficial puede no

ser aceptado por destinos que exigen que el documento provenga de una autoridad veterinaria oficial del país de origen. El mismo contenido clínico, sin el endoso, puede ser insuficiente para cumplir con los requisitos de importación.

Diferencia clave: certificado veterinario vs. documento oficial endosado
Certificado veterinario: emitido por veterinario en ejercicio privado. Declaración técnica individual. Validez = criterio del profesional firmante. Certificado oficial endosado: revisado y validado por autoridad sanitaria competente del Estado. Documento oficial respaldado por la autoridad emisora. Requisito en numerosos destinos.

6.2 Ejemplos de sistemas con endoso: marcos verificados en esta serie

Dos sistemas regulatorios analizados en detalle en artículos anteriores de esta serie ilustran con claridad la distinción:

Sistema de la Unión Europea (para movimiento desde terceros países): el Reglamento (UE) 576/2013 y sus reglamentos de ejecución establecen modelos de certificado sanitario oficial que deben ser emitidos por el veterinario oficial del país de origen. No es suficiente un certificado de veterinario privado: el documento debe corresponder a un modelo aprobado y debe ser firmado por un veterinario con estatus oficial reconocido. Este sistema representa un endoso integrado en el propio formato del documento.

Animal Health Certificate del Reino Unido: el AHC que exige DEFRA/APHA para la entrada de animales a Gran Bretaña debe ser emitido por un veterinario oficial acreditado (Official Veterinarian, OV) habilitado por la autoridad competente. Un veterinario privado sin esa acreditación específica no puede emitir un AHC válido, independientemente de su competencia clínica. El documento en sí ya constituye el endoso, porque su emisión está reservada a profesionales habilitados por la autoridad.

6.3 Implicaciones para el proceso de exportación

La existencia de requisitos de endoso o de certificación oficial tiene implicaciones logísticas directas que deben integrarse en la planificación del proceso de exportación:

- El veterinario que realizará el examen clínico debe estar habilitado específicamente para emitir el tipo de documento exigido por el destino, no solo para ejercer la medicina veterinaria en general.
- Los procesos de endoso por autoridades sanitarias pueden tener tiempos de tramitación que no son compatibles con ventanas temporales de validez muy cortas. La coordinación entre la fecha del examen, la fecha del endoso y la fecha del viaje debe planificarse con margen suficiente.
- El modelo de documento a utilizar debe ser verificado en el sitio oficial de la autoridad del destino antes de la emisión, no después. Un endoso sobre un modelo de documento no aceptado por el destino carece de validez.

Para todos los destinos no analizados explícitamente en esta serie, la pregunta correcta no es «¿necesito certificado de salud?» --la respuesta es invariablemente sí-- sino «¿qué tipo de documento se requiere, quién puede emitirlo y en qué formato?» La respuesta a esa pregunta solo puede provenir de la autoridad sanitaria competente del destino.

Sección 7 Operadores de transporte: requisitos paralelos al marco estatal

7.1 Regulación estatal vs. política operacional: dos capas superpuestas

El marco regulatorio estatal del movimiento internacional de animales --las normativas de los países de origen, tránsito y destino-- establece los requisitos mínimos para la importación legal del animal. Sin embargo, el transporte aéreo de animales añade una segunda capa de requisitos: la política operacional del operador de transporte, que puede ser más restrictiva que la normativa estatal y que no está sometida a los mismos procesos de publicación y actualización que la normativa oficial.

Esta superposición genera una situación en la que un propietario puede haber cumplido todos los requisitos regulatorios estatales para mover a su animal y encontrarse, en el momento del embarque, con que el operador de transporte tiene condiciones adicionales que no estaban incluidas en su preparación. La ignorancia de la política del

operador es, desde la perspectiva del sistema de transporte, responsabilidad del remitente.

7.2 Documentación adicional que pueden requerir los operadores

Los operadores de transporte aéreo --aerolíneas para animales en cabina o en bodega, servicios courier especializados en pet relocation, operadores de carga aérea-- pueden requerir, con independencia de lo que exija la normativa del destino, documentos adicionales orientados a gestionar su propio riesgo operacional:

- Declaración de aptitud para el vuelo (fit to fly): un documento específico, distinto del certificado de salud general, en el que el veterinario declara que el animal es apto específicamente para el transporte aéreo en las condiciones previstas del vuelo concreto. Este documento puede tener su propio formato, su propia ventana temporal y sus propios requisitos de emisión según el operador.
- Formularios propios del operador: algunas aerolíneas y operadores especializados tienen sus propios formularios que deben ser completados por el veterinario, separadamente o en adición al certificado de salud oficial.
- Restricciones por especie, raza o condición: los operadores pueden prohibir o condicionar el transporte de determinadas razas (principalmente braquicéfalas), rangos de edad (cachorros muy jóvenes, animales geriátricos), o animales con determinadas condiciones médicas, con independencia de que la normativa del destino no contemple esa restricción.
- Requisitos de transportín: las especificaciones de dimensiones, material, sistema de cierre y ventilación del transportín son frecuentemente más detalladas en las políticas de los operadores que en la normativa regulatoria. La no conformidad del transportín puede ser causa de rechazo del embarque.

7.3 La gestión del gap entre normativa y política operacional

El gap entre lo que la normativa estatal exige y lo que el operador de transporte requiere puede gestionarse con un principio sencillo: siempre verificar directamente con el operador específico que realizará el transporte, con el tiempo suficiente para que cualquier requisito

adicional pueda cumplirse antes del día del viaje.

Las políticas de los operadores no se publican de la misma forma que la normativa oficial. Pueden cambiar sin aviso previo, pueden variar entre rutas del mismo operador, y pueden tener excepciones que solo se conocen contactando directamente con el área de carga viva o servicios especiales del operador. La información de terceros --incluyendo artículos técnicos como este-- no sustituye esa verificación directa.

Sección 8 Limitaciones y responsabilidad profesional

8.1 El certificado reduce el riesgo pero no elimina la incertidumbre biológica

El sistema documental completo que acompaña a un animal en un movimiento internacional --microchip, vacunaciones, RNATT cuando aplica, tratamientos antiparasitarios, certificado de salud, certificado oficial endosado-- es el mejor sistema disponible para gestionar el riesgo colectivo asociado al movimiento de animales a través de fronteras. No es un sistema perfecto, ni puede serlo, porque opera sobre información necesariamente incompleta respecto al estado biológico real de cada individuo.

La incertidumbre biológica es irreductible con los instrumentos de evaluación actuales. Un animal puede superar todos los controles documentales y clínicos disponibles y aun así ser portador de un agente infeccioso que no produce signos clínicos, que no está cubierto por ninguna de las vacunas exigidas, o que se encuentra en un período de incubación demasiado corto para haber sido detectado en el examen. El sistema de control asume esta limitación y la gestiona reduciendo la probabilidad de que eso ocurra a niveles aceptables para sus objetivos de salud pública, no eliminándola.

8.2 Regulaciones cambiantes: el imperativo de la verificación actualizada

A lo largo de esta serie técnica, y en particular en los artículos sobre certificados de vacunación y certificados de salud, se ha repetido una advertencia que no es retórica: las regulaciones cambian con frecuencia. Esta frecuencia no es uniforme: algunos marcos

regulatorios son estables durante años, otros se modifican con cada nueva evidencia epidemiológica, cada brote de enfermedad relevante, o cada cambio de política sanitaria de los gobiernos implicados.

El veterinario que trabaja en medicina de viajes internacionales de animales de compañía no puede basarse en el conocimiento adquirido en un momento determinado para tomar decisiones en un momento posterior sin verificación. La distancia temporal entre la adquisición de un conocimiento regulatorio y su aplicación puede ser suficiente para que ese conocimiento sea incorrecto. La única garantía razonable de cumplimiento documental es la verificación directa con la autoridad competente en el momento de la emisión.

8.3 El alcance de este artículo y sus limitaciones propias

Este artículo describe principios, marcos conceptuales y patrones de error. No proporciona listas de requisitos por país porque esas listas caducan y su inclusión aquí generaría una falsa sensación de completitud y actualización que podría ser más peligrosa que la ausencia de esa información. El criterio editorial de esta serie ha sido consistente desde el primer artículo: rigor antes que exhaustividad, y honestidad sobre los límites antes que compromisos de completitud que no pueden mantenerse.

Sección 9 Síntesis final

El certificado de salud es la interfaz entre la biología clínica y el control sanitario internacional. Es el punto donde el estado de un organismo vivo --continuo, dinámico, parcialmente opaco a la evaluación externa-- se convierte en un documento estático, estandarizado y verificable que puede acompañar a ese organismo a través de sistemas de control diseñados para procesar información, no individuos biológicos.

La calidad de ese documento, y con ella su utilidad real como instrumento de control sanitario, depende de cuatro condiciones que deben cumplirse simultáneamente:

- Examen clínico real y documentado: un examen realizado con la rigurosidad que el contexto exige, con hallazgos registrados de forma fiel, en un animal que es el

mismo que el que figura en los documentos del expediente.

- Identificación correcta y coherente: el número de microchip ISO verificado en el animal y registrado de forma exacta e idéntica en cada documento del expediente, desde la primera vacunación hasta el último documento del proceso.
- Cumplimiento normativo vigente al momento de la emisión: el formato correcto, la habilitación adecuada del emisor, el endoso oficial cuando sea exigido, los plazos respetados. No el cumplimiento de lo que la normativa exigía hace seis meses, sino lo que exige en el momento exacto en que el documento se emite.
- Coherencia de la cadena documental completa: cada documento del expediente es individualmente correcto y todos son coherentes entre sí. Las fechas son compatibles, las descripciones del animal son consistentes, y el número de microchip es el mismo en todos y cada uno de ellos.

Cuando estas cuatro condiciones se cumplen, el certificado de salud desempeña su función: acreditar ante el sistema de control que el animal que lo porta llegó a ese punto mediante un proceso médico y documental verificable. Cuando alguna falla, el documento pierde esa capacidad, independientemente de la corrección de las demás.

Esa interdependencia --no la complejidad de ninguno de los pasos individuales-- es lo que hace del proceso de certificación en medicina de viajes veterinaria una disciplina que requiere atención sistemática, verificación continua y actualización permanente. La competencia en ese espacio no es estática: se construye y se mantiene.

Referencias

- Unión Europea. Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al desplazamiento sin carácter comercial de animales de compañía. Diario Oficial de la Unión Europea, L 178, 1-26.
- United Kingdom Government. GOV.UK -- DEFRA/APHA. Bringing your pet dog, cat or ferret to Great Britain. <https://www.gov.uk/bring-pet-to-great-britain>
- Australian Government. Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF). Importing cats and dogs into Australia. <https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs>
- New Zealand Government. Ministry for Primary Industries (MPI). Importing dogs and cats (CATDOG.GEN). <https://www.mpi.govt.nz/importing/animals/importing-dogs-and-cats/>
- ISO 11784:1996. Radio Frequency Identification of Animals -- Code Structure. International Organization for Standardization.
- ISO 11785:1996. Radio Frequency Identification of Animals -- Technical Concept. International Organization for Standardization.
- International Air Transport Association (IATA). Live Animals Regulations (LAR), 51st Edition (2025). <https://www.iata.org/en/publications/store/live-animals-regulations/>
- Federal Aviation Administration (FAA). 14 CFR Part 25.841 -- Pressurized cabins. <https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-C/part-25/subpart-D/section-25.841>
- Gowing, F. (2015). Pet travel: Air transport of dogs and cats. In Practice (Vet Record), 37(10), 516-525. <https://doi.org/10.1136/inp.h5618>
- Leadbeater, K., et al. (2021). The welfare of dogs during transport. Veterinary Record, 189(2), e504. <https://doi.org/10.1002/vetr.611>
- World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). Guidelines for the Vaccination of Dogs and Cats (2016). Journal of Small Animal Practice, 57(1), E1-E45.

Figure 1. Health-certificate validity at destination — decision flowchart.

All five conditions are conjunctive (AND-logic). The exact temporal window and endorsement requirement depend on the destination and must b

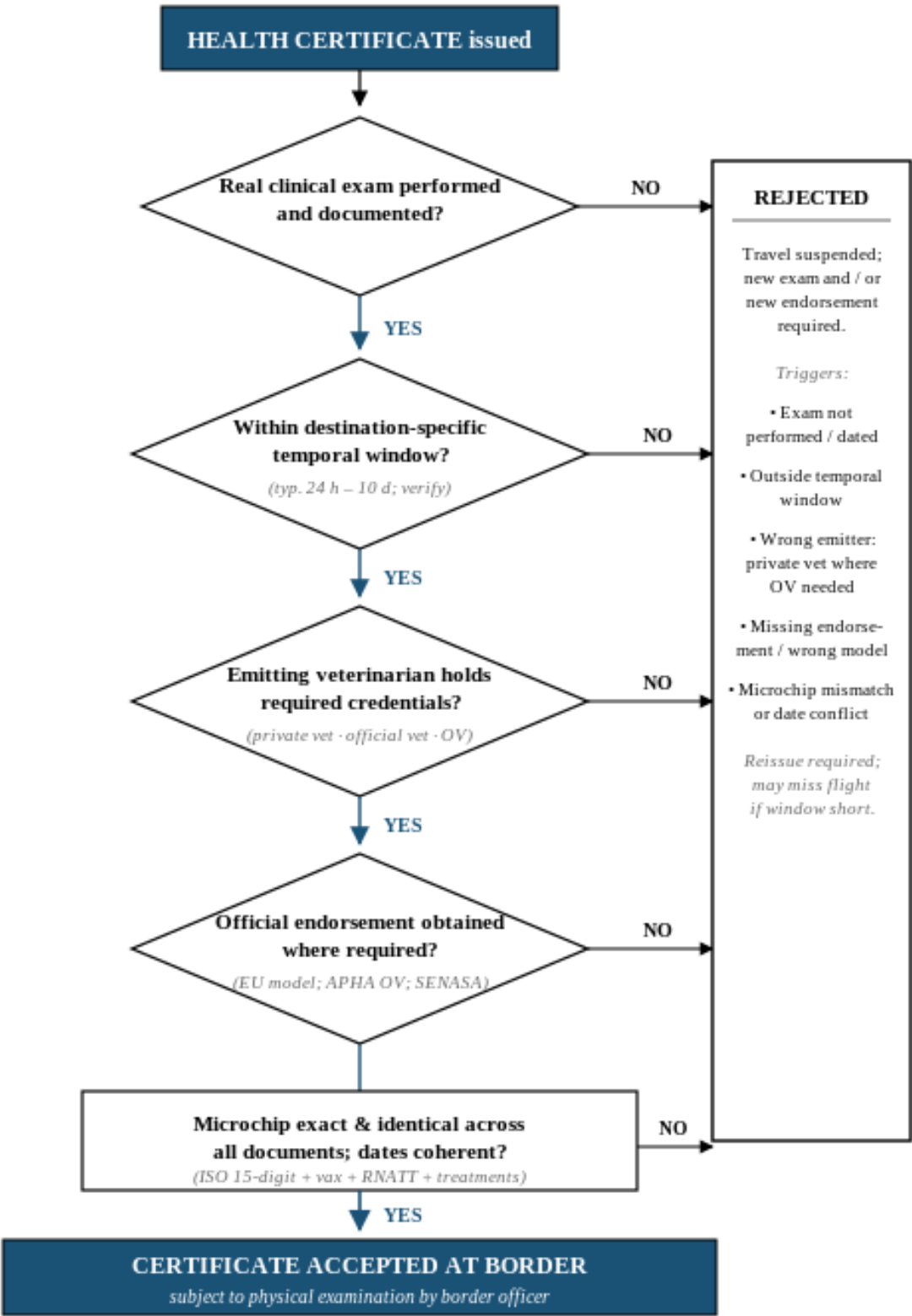


Figure 2. Private veterinary certificate vs. officially endorsed certificate — comparative matrix.

Synthesis of EU Reg. 576/2013, UK APHA AHC scheme, AU DAFF, NZ MPI. Direct verification with each authority is required before emission.

Attribute	Private veterinary certificate <i>individual professional responsibility</i>	Officially endorsed certificate <i>state-level authority document</i>
European Union Reg. (EU) 576/2013 Intra-EU + third country routes	Status: Insufficient for third-country entry Emitter: Any habilitated private vet Use: Pre-export clinical screening only <i>Border officer requires endorsed version</i>	Model: Impl. Reg. 577/2013 Annex IV Emitter: Official veterinarian (state) Window: ≤ 10 d before entry <i>In Peru: SENASA-accredited official vet</i>
United Kingdom APHA / DEFRA Pet Travel Animal Health Certificate (AHC) — post-Brexit	Status: Not accepted as AHC Emitter: Private vet — no OV status Use: Internal clinical documentation <i>AHC reserved to APHA-habilitated OVs</i>	Model: Animal Health Certificate Emitter: Official Veterinarian (OV) Window: ≤ 10 d before entry, single use <i>OV credential issued by APHA</i>
Australia DAFF Biosecurity Act Import permit + Health Certificate per group	Status: Not accepted alone Emitter: Private vet Use: Pre-RFFIT and pre-protocol <i>Requires official certification chain</i>	Model: Group-specific veterinary cert. Emitter: Government-approved vet Window: ≤ 5 d before export <i>+ import permit issued in advance</i>
New Zealand MPI · IHS CATDOG.GEN Import Health Standard veterinary certificate	Status: Not accepted alone Emitter: Private vet Use: Pre-protocol clinical record <i>Official certification mandated by IHS</i>	Model: MPI veterinary certificate Emitter: Official vet (country of origin) Window: ≤ 5 d before export <i>+ pre-issued MPI import permit</i>

Convergent rule — in every analysed jurisdiction, the private veterinary certificate is necessary but not sufficient. The state endorsement (or its functional equivalent under EU and UK schemes, where the emitter must already hold official status) is the document that the border officer accepts. In Peru, the official veterinarian for export is the SENASA-accredited veterinarian.

■ Private veterinary certificate ■ Officially endorsed certificate (border-grade)

World Organisation for Animal Health (WOAH/OIE). Terrestrial Animal Health Code --
Chapter on Certification.

<https://www.OIE/WOAH.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/>

Nota de navegación: esta Serie Técnica está interconectada. Los enlaces internos apuntan a
desarrollos complementarios (no a requisitos por país).

Herramienta práctica

¿Tu mascota puede volar en tu fecha exacta?

Calcula en tiempo real: FAVN, microchip, vacuna, cuarentena y requisitos de 22 países.

Semáforo rojo/ámbar/verde + timeline inverso + PDF.